

Cas clinique 1

Une jeune de 20 ans consulte pour une névralgie faciale droite avec diplopie. L'examen trouve une hypoesthésie du front et de la joue supérieure à droite et une immobilité de l'œil droit au regard extérieur. La malade est envoyée en consultation ORL pour examen. L'endoscopie du cavum trouve une tumeur bourgeonnante postéro-latérale droite du cavum.

Le diagnostic de carcinome du nasopharynx est porté.

1. L'atteinte neurologique est liée à :

- A. Paralysie du II droit
- B. Paralysie du III droit
- C. Paralysie du IV droit
- D. Paralysie du V1 et V2 droits
- E. Paralysie du VI droit

2. Comment expliquer anatomiquement l'atteinte constatée au niveau de l'œil droit ?

- A. Extension au niveau de la fossette de Rosen Muller
- B. Extension au niveau de la Fosse infratemporale
- C. Extension au niveau de la base du crâne
- D. Extension au niveau du sinus caverneux
- E. Extension au globe oculaire

3. Dans le bilan d'extension tumorale :

- A. La scintigraphie osseuse est systématique
- B. L'IRM du cavum est l'examen de première intention
- C. Le scanner thoracique est demandé
- D. L'IRM abdominale est systématique pour rechercher une métastase hépatique
- E. La radio-panoramique dentaire est demandée

4. L'atteinte nerveuse constatée chez cette malade :

- A. Est un facteur pronostique péjoratif
- B. Son traitement repose sur la chimio-radiothérapie
- C. Classe la tumeur en un 'T3'
- D. Impose une chirurgie ganglionnaire dans l'arsenal thérapeutique
- E. Entre dans le cadre du syndrome paranéoplasique

Cas clinique 2

Une femme de 32 ans, consulte pour douleur pelvienne et métrorragie. La date des dernières règles remonte à 15 jours. Elle est sous contraception mécanique par stérilet au cuivre depuis 3 ans. L'examen physique est sans anomalies.

5. Les diagnostics à évoquer chez cette femme :

- A. Une ovulation
- B. Une pathologie néoplasique utérine
- C. Un effet mécanique du stérilet
- D. Une infection génitale haute
- E. Une endométriose ovarienne

6. Le bilan biologique a montré un taux de BHCG à 800 UI/l, la conduite à tenir est :

- A. Refaire une BHCG après 48 heures
- B. Faire une échographie par voie endovaginale
- C. Retirer le stérilet
- D. Hospitaliser la patiente
- E. Indiquer une coelioscopie diagnostique étant donné que la patiente est symptomatique

7. Le diagnostic de grossesse extra-utérine droite est retenu, la patiente est proposée pour un traitement médical si :

- A. Absence de pseudo sac intra-utérin
- B. Le taux de BHCG est inférieur à 10000 UI/l
- C. Présence d'une contre-indication à la coelioscopie
- D. Etat hémodynamique stable
- E. Absence d'accentuation des douleurs pelviennes

8. La surveillance du traitement médical de la grossesse extra-utérine comporte :

- A. Un taux de BHCG au 4^{ème} jour
- B. Une échographie pelvienne au 4^{ème} jour
- C. La palpation abdominale pluriquotidienne
- D. Une évaluation de la tension artérielle
- E. Un examen gynécologique quotidien

9. L'apparition d'une douleur pelvienne intense au niveau de la fausse iliaque droite :
- A. Est un effet indésirable du traitement médical
 - B. Indique une échographie pelvienne de contrôle
 - C. Evoque une appendicite aigue associée
 - D. Est un signe d'échec du traitement médical
 - E. Impose une salpingectomie

Cas clinique 3

Mr Salah, âgé de 58 ans diabétique sous métformine 850 1cp*2/j depuis 3ans, grand tabagique 80 PA, se présente à la salle d'urgence pour une douleur thoracique constrictive au repos depuis 3 jours

A l'examen :

Eupneique, non algique

PA = 100/70 mmHg , Fc = 40 b /min

Poids = 90 Kg, taille = 1.62 m

Auscultation cardiopulmonaire : souffle systolique au foyer mitral

Turgescence des veines jugulaires.

ECG : sus décalage de ST en inferieur et en V3R, V4R, avec aspect de miroir en antérieur, dissociation auriculo-ventriculaire. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu (SCA) ST+ est retenu

10. Quels sont les facteurs de risques modifiables chez ce patient :

- A. Age
- B. Obésité
- C. Tabagisme
- D. Diabète
- E. HTA

11. Quelles sont les complications du SCA ST+ suspectées chez ce patient ?

- A. Trouble de rythme grave
- B. Extension au VD
- C. Bloc-auriculo ventriculaire complet
- D. Insuffisance mitrale ischémique
- E. Tamponnade

12. Le traitement de première intention instauré pour améliorer les conditions hémodynamiques chez ce patient est:

- A. Isuprel à la seringue électrique
- B. Dobutamine à la seringue électrique
- C. Drainage péricardique
- D. Atropine en IVD
- E. Adrénaline à la seringue électrique

13. Quels traitements anti-thrombotique instaurez-vous chez ce patient ?

- A. Ticagrelor 180 mg/j par voie orale
- B. Clopidogrel 75 mg
- C. Enoxaparine 60 mg/j en sous cutané
- D. Aspegic 250 mg en IVD
- E. Héparine 50 mg en IVD

Chez ce patient, une coronarographie a été réalisée, elle a montré une occlusion chronique de l'interventriculaire antérieure et une occlusion aigue de la coronaire droite qui a été traitée avec mise en place d'un stent actif, à la sortie de la salle de cathétérisme, PA= 130/80 mmHg, Fc= 75 battements/min, FeVG = 35% avec hypokinésie

14. Quels traitements de sortie prescrivez-vous ?

- A. Atorvastatine 10 mg/j
- B. Rosuvastatine 20 mg/j
- C. Ticagrelor 90mg*2/j pendant 12 mois
- D. Ramipril 2.5 mg /j à ajuster à la pression artérielle
- E. Anti-aldosterone 25 mg/ j à ajuster à la fonction rénale et kaliémie

Cas clinique 4

Un patient âgé de 38 ans , au ATCD d'un RAA, consulte pour une fièvre à 38°C – 38.5°C évoluant depuis 15 jours accompagnée de lombalgies et de sueurs. Il a eu une extraction dentaire il y a 20 jours sans antibio-prophylaxie. A l'examen, vous notez l'existence d'un souffle systolique intense au foyer aortique, déjà connu du patient.

15. Les signes en faveur d'une endocardite sont

- A. Le purpura pétéchial
- B. L'hématurie microscopique
- C. Le pseudo-paranis de la pulpe des doigts
- D. La splénomégalie
- E. La Cyanose des extrémités

16. Le germe qui est le plus en cause de l'endocardite

- A. Le Streptocoque bêta hémolytique A
- B. Le Staphylocoque doré
- C. Le Streptocoque viridans
- D. L'entérocoque
- E. Le Pneumocoque

17. Les examens qui permettront de confirmer le diagnostic d'endocardite sont

- A. Hémocultures
- B. Echocardiographie
- C. ECG
- D. Radiographie pulmonaire
- E. Recherche de complexes immuns circulants

18. Le traitement probabiliste de première intention est

- A. Erythromycine IV + Tétracycline per os
- B. Pefloxacin per os
- C. Amoxicilline per os
- D. Pénicilline G IV + Nétilmycine IM $\times 2$
- E. Ampicilline IV+ genta IV+ oxacilline IV

Cas clinique 5

Un homme âgé de 27 ans est amené parce qu'il a agressé ses voisins. A l'entretien, il est instable, irritable et incurie. Il murmure seul puis il avoue qu'il entend des voix qui lui donnent des ordres, l'empêchent de dormir et dit que ses voisins veulent lui nuire. Tout ceci évoluait depuis trois ans. L'examen somatique et les bilans sont sans particularités

19. Les éléments sémiologiques de cette observation sont

- A. Délire de persécution
- B. Excitation psycho-motrice
- C. Hallucinations visuelles
- D. Syndrome d'influence
- E. Trouble du sommeil

20. Quel est votre premier diagnostic ?

- A. Schizophrénie
- B. Trouble bipolaire
- C. Trouble délirant
- D. Trouble psychotique bref
- E. Trouble schizophréniforme

21. Quelles sont les modalités thérapeutiques immédiates ?

- A. Antidépresseurs par voie orale
- B. Anxiolytiques en monothérapie
- C. Hospitalisation
- D. Neuroleptiques injectables
- E. Thymorégulateurs associés aux antidépresseurs

22. Le patient a été mis sous aripiprazol. Cette molécule :

- A. Agit sur les symptômes productifs et déficitaires
- B. Donne plus de syndrome métabolique
- C. Est mal tolérée sur le plan neurologique
- D. Est un antipsychotique atypique
- E. Est un neuroleptique retard

Cas clinique 6

Un jeune homme âgé de 25 ans, sans ATCD pathologiques, se présente aux urgences pour une douleur importante du MI droit apparue depuis 4 heures, associée à une froideur et à une impotence fonctionnelle totale du membre.

L'examen aux urgences trouve un membre froid, pâle, début de cyanose, une anesthésie cutanée, et paralysie modérée du membre, et tous les pouls sont abolis. L'auscultation cardiaque trouve un rythme irrégulier, sans souffle.

Le diagnostic d'ischémie aiguë du MI droit est retenu.

23. L'étiologie la plus probable de cette ischémie aiguë est:

- A. Embolie sur artères saines.
- B. Embolie sur artères pathologiques.
- C. Thrombose sur artères pathologiques.
- D. Embolie paradoxale.
- E. Anévrysme aortique

24. Quel est le stade clinique qui correspond à ce tableau d'ischémie aiguë

- A. I
- B. II a
- C. II b
- D. III
- E. IV

25. L'héparine chez ce patient est indiquée:

- A. Uniquement en pré-opératoire sous forme de bolus.
- B. Pour prévenir l'extension du thrombus.
- C. Uniquement en post-opératoire.
- D. En pré, en per, et en post opératoire.
- E. Pour agir sur le caillot constitué.

26. Le geste chirurgical chez ce patient est

- A. Une thrombo-aspiration.
- B. Une embolectomie à la sonde de Fogarty.
- C. Un pontage vasculaire.
- D. Une thrombo-endartériectomie.
- E. Une Aponévrotomie.

27. Parmi les complications suivantes, celles qui peuvent être observées en post-opératoire après une embolectomie à la sonde de Fogarty sont:

- A. Insuffisance rénale aiguë.
- B. Hypokaliémie.
- C. Rethrombose de l'artère désoblitérée.
- D. Alcalose métabolique.
- E. Oligurie.

Cas clinique 7

Une recto-sigmoidoscopie faite chez un patient âgé de 65ans a montré la présence d'une lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, à 6 cm de la marge anale. Les biopsies de cette tumeur ont conclu à un adénocarcinome bien différencié. Après un bilan d'extension par TDM TAP et IRM pelvienne la tumeur a été classée T3N+M0.

28. Quel traitement envisagez-vous :

- A. Une amputation abdomino-périnéale précédée d'une radio-chimiothérapie
- B. Une résection antérieure du rectum précédée d'une radio-chimiothérapie
- C. Une résection chirurgicale de la tumeur par voie endo anale
- D. Une intervention de Hartmann
- E. Une radiothérapie puis colectomie totale

L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire montre la présence d'un adénocarcinome bien différencié classé T3N1M0 avec engainement péri nerveux et embolies vasculaires.

29. Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez ce patient :

- A. L'atteinte en profondeur de la paroi colique
- B. L'atteinte ganglionnaire
- C. L'engainement péri-nerveux
- D. Le caractère bien différencié de la tumeur
- E. L'aspect végétant ou ulcéreux de la tumeur

30. Quel est votre CAT en post opératoire ?

- A. Une surveillance clinique uniquement
- B. Une hormonothérapie
- C. Une radio-chimiothérapie adjuvante
- D. Une chimiothérapie adjuvante
- E. Une curie thérapie endo anale adjuvante

31. Votre protocole de surveillance comporte :

- A. Une coloscopie totale
- B. Un scanner pelvien seulement
- C. Une échographie abdomino-pelvienne
- D. Un scanner tap
- E. Un dosage de l'antigène carcino-embryonnaire

Cas clinique 8

Amine 7 ans, est adressé à la consultation pour exploration d'une dyspnée sifflante à répétition.

A l'interrogatoire: né à terme par césarienne, il a présenté un eczéma pendant sa 1^{ère} année de vie. Depuis 1 an, il a fait 4 épisodes de dyspnée, traité par nébulisation de bronchodilatateurs à courte durée d'action (BDCA) aux urgences et corticothérapie par voie générale. Il a été mis sous aérol à la demande lors du dernier épisode. En inter critique, il a une toux nocturne quotidienne et une gêne à l'effort. Il a aussi un prurit nasal et sa mère est asthmatique

A l'examen :

- Poids= 45 Kg (+3DS), Taille= 124 cm (+1 DS)
- Eupnéique avec auscultation cardio-pulmonaire: normale
- La peau est sèche, Examen ORL: obstruction nasale
- Pas de déformation, pas d'hippocratisme digital
- Reste de l'examen: normal

32. Les autres éléments anamnestiques à rechercher sont :

- A. Les facteurs déclenchants des exacerbations
- B. La notion d'élevage d'animaux
- C. La notion de tabagisme passif
- D. La notion de contact tuberculeux
- E. La notion d'humidité dans l'habitat

33. Les éléments de mauvais contrôle de l'asthme chez Amine sont :

- A. La toux nocturne quotidienne
- B. La dyspnée d'effort
- C. L'obésité
- D. La présence d'une rhinite allergique associée
- E. La présence d'une atopie parentale

34. Les examens complémentaires à demander sont :

- A. EFR
- B. Radiographie thoracique
- C. PH-métrie œsophagienne
- D. Tests cutanés
- E. Dosage des IgE totales

35. La prise en charge thérapeutique comporte

- A. Bronchodilatateurs à longue durée d'action quotidienne
- B. Corticostéroïdes inhalés (csi) à dose faible
- C. Csi à dose faible avec à chaque administration des bronchodilatateurs à courte durée d'action
- D. Corticothérapie par voie générale
- E. Proscrire le tabagisme passif

Cas clinique 9

Monsieur X, âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques, se plaignait d'une toux persistante et il a deux bascilloscopies positives sur les crachats. Une tuberculose pulmonaire est alors confirmée. La déclaration étant faite, et le bilan préthérapeutique aussi. Une quadruple thérapie antituberculeuse était démarrée. A 2 mois de traitement, les recherches de BK(RBK) sont encore positives.

36. Les mesures nécessaires pour ce patient sont :

- A. Un scanner thoracique
- B. Une PCR gène expert
- C. Chercher une résistance sur les cultures des BK
- D. Vérifier l'observance
- E. Une fibroscopie bronchique

37. L'enquête réalisée a été sans anomalies, votre conduite à tenir thérapeutique serait de :

- A. Switcher vers d'autres antituberculeux de 2ème ligne
- B. Ajouter la streptomycine
- C. Arrêter la quadrithérapie antituberculeuse et passer à la bithérapie (INH, Rifampicine)
- D. Arrêter les antituberculeux mineurs et les remplacer par des antituberculeux de 2ème intention
- E. Refaire des RBK

38. Comment étudier l'état des bacilles acido-alcolo- résistants identifiés sur l'examen direct des crachats de ce malade?

- A. PCR gène expert
- B. Culture des BK sur milieu de Lowstein Jensen
- C. TDM thoracique
- D. Coloration du frottis à l'auramine
- E. Coloration à la fuschine